

Información Paciente

Nombre : Hernán Ricardo Flores Ascencio **Rut** : 15.917.400-K **N° Archivo** : 0626324
Edad : 37a 7m 26d **Fecha Nacto**: 19/08/1984 **Sexo** : Masculino
Dirección : Pje. Alberto Valenzuela B-0675 Dpto 15 **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 966913121

N° Epicrisis
302995

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso** : 12/02/2022 00:54 **Días Estadía**: 61
Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad **Fecha Egreso** : 14/04/2022 20:04

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Politraumatizado

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Antecedentes:

AM: (-)

Qx: (-)

Alergias: (-)

Habitos: policonsumo de sustancias.

Fcos: no.

Anamnesis:

Paciente traído por SAMU, tras presentar herida por arma blanca en zona escapular izquierda y lumbar izquierda. Al ingreso al reanimador, mal perfundido, hipotenso, taquicárdico, sudoroso, en sopor superficial. Con evidente hemotórax izquierdo, se le instala tubo pleural, se toma PAN-TAC que muestra hematoma retroperitoneal y hemotórax izq. Ingresó a Pabellón de urgencia, se activó protocolo de transfusión masiva. Laparotomía exploradora, sin hemoperitoneo, a nivel del polo renal izquierdo hematoma pequeño, no expansible, se diseca hasta pedículo renal, sin evidencia de mayor compromiso a nivel del hilio, por lo que se decide no abrir a retroperitoneo.

En post operatorio inmediato con profundización del shock por lo que se decide realizar laparotomía exploradora donde se evidenció hemoperitoneo masivo. Se identificó laceración de aorta suprarrenal en cara posterior izquierda del cual se hizo rafia. Tuvo 2 periodos de clampeo (1:30 y 30 min). En mismo tiempo quirúrgico se exploró tórax sin sangrado evidente, se decidió ligar LIMA. Se evidenció defecto diafragmático en receso posterior que no se pudo corregir. Quedó con dos drenajes pleurales y laparotomizado con salida a recuperación y posteriormente a UPC.

Durante pabellón recibió en total 22 u GR, 310 cc de PFC, 280 cc de plaquetas, 350 mL de crioprecipitado, 12 lts de cristaloideos, 500 cc de HCO₃ y 1000 cc de Voluven. Post operatorio inmediato en shock profundo con noradrenalina y adrenalina en dosis altas.

En estas condiciones ingresó a UCI para continuar manejo.

Diagnósticos Ingreso:

Herida penetrante tóraco-abdominal por arma blanca

Shock hipovolémico-hemorrágico

Hemotórax y hemoperitoneo masivo

Laceración de aorta suprarrenal reparada.

Fecha Epicrisis : 17/05/2022 17:39

Fecha Última Actualización: 17-05-2022 17:39:48

Página 2 de 4

Pleurostomía izquierda doble.
Laparotomizado

Evolución por sistemas en UPC:

1. Hemodinámico: Al ingreso en shock profundo requiriendo 2 drogas para mantener perfusión, politrasfundido. En un inicio hipovolémico por trauma aórtico y sangrado masivo, posteriormente componente distributivo por peritonitis secundaria y pancreatitis comentada más abajo. Buena evolución en lo hemodinámico logrando suspensión de drogas. Posteriormente, cursó con un shock séptico en contexto de una bacteriemia que se atribuyó a ITS CVC. Al momento del traslado estable, más bien con tendencia a la hipertensión que podría estar en contexto de hiperadrenergia por lo cual está con atenolol. Anemia politransfundida inflamatoria y por pérdidas dado poli- intervenido.

2. Respiratorio: VMI en contexto quirúrgico, shock y hemotórax, con weaning dificultoso por Intercurrencias infecciosas y quirúrgicas. Estuvo ventilado desde ingreso 12/02/22, con salida a TQT percutánea el 21/03/22 y destete del ventilador 10/04/22. Al momento del traslado ventilando en filtro, con escasos requerimientos de oxígeno, buena mecánica.

3. Cirugía tórax: doble pleurostomía por hemotórax. Retiro del primer drenaje 23/02. En contexto de síndrome febril y una imagen al TAC de tórax de una colección no abarcada por pleurostomía se decidió drenaje en pabellón 16/02 drenaje, aseo, pleurodesis y reparación de una laceración diafragmática, sin evidencia del defecto diafragmático posterior. Requirió nuevo aseo el 25/03 por abundantes coágulos que tapaban drenaje, además se realizó segunda pleurodesis. Finalmente retiro de tubo pleural 04/04. Impresiona conflicto resuelto.

4. Infeccioso: Resumen de Intercurrencias:

a. Peritonitis por SAMR y C. albicans. Recibió esquema prolongado vancomicina/fluconazol según cultivos e imipenem empírico. Imipenem y vancomicina ya suspendidos.

b. Shock séptico con bacteriemia por S. marcescens NDM y C. albicans (HC 08/03). Cultivo de catéter con mismos agentes UFC 15. HCs control 11/03 negativos. Completó 24/03 Ceftazidima/avibactam/aztreonam.

c. En relación a lo anterior candidiasis invasora con candidemia y probable retinitis por candida, recibiendo fluconazol en dosis altas. Seguimiento por oftalmología. A la espera de ecocardio.

d. Neumonía multilobar objetivada TAC de tórax de 16/03. LBA 22/03 a la fecha BK y GeneXpert (-), cultivo corriente con C. glabrata, galactomanano (-).

Cobertura actual es fluconazol, PCR lentamente a la baja, curva febril impresiona en descenso. Último control imagenológico 04/04 con persistencia de colección perirrenal izquierda de menor tamaño. A la espera de ecocardio TT en búsqueda de implantes de candida, al menos sin imágenes sospechosas en ecocopia.

5. Quirúrgico: Laparotomía explorado inmediata, requiriendo reintervención precoz por hemoperitoneo masivo por una lesión aórtica ya reparada con una rafia, quedando laparotomizado. Posteriormente con shock distributivo y con aspecto intraoperatorio e imagenológico de pancreatitis que requirió de necrosectomía. En nueva intervención para intento de cierre se objetivó una perforación duodenal puntiforme que se hizo rafia. El 02/03 se hizo cierre de pared abdominal, con dehiscencia de cicatriz precoz, que se manejo con VAC, requiriendo múltiples aseos y recambios. 04/04 se realiza cierre de pared abdominal, sin embargo al momento del traslado con dos áreas dehiscentes. Tiene dos drenajes in situ, uno al espacio perirrenal izquierdo donde hay una colección organizada que ha ido disminuyendo de tamaño en controles imagenológicos. El otro drenaje está en relación a la unión gastro-duodenal sin colecciones en su trayecto.

6. Medio interno: Cursó con injuria renal aguda en relación a episodios de shock, que corrigió rápidamente con medidas de soporte, no fue mayor conflicto.

7. Metabólico: Requirió NPT prolongada desde el 26/02 al 06/04. Actualmente recibiendo nutrición enteral bien tolerada, en seguimiento por equipo de ANI. HGT en rango.

8. Rehabilitación:

a. Delirium: Historia de policonsumo y uso prolongado de sedantes y opioides en dosis altas. Destete de sedación endovenosa fue dificultosa por agitación sicomotora, requirió de múltiples fármacos. Al momento del traslado conectado, pero a ratos intranquilo. Recibiendo Diazepam, metadona y risperidona horario, además de atenolol como manejo de la adrenergia.

b. FNA: En rehabilitación, sin posibilidad de régimen oral de momento. No tolera desinflado de cuff.

c. Motor: polineuropático en rehabilitación. Movilizándose en cama. M3-4 en EESS distal. M3 en EEII distal.

Diagnósticos de egreso de UCI 14/04/22:

Candidiasis invasora por C. albicans, HC 08/03 (+), implantes retinales y peritonitis en tratamiento.

Fecha Epicrisis : 17/05/2022 17:39

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 17-05-2022 17:39:48

Página 3 de 4

Herida penetrante toraco abdominal:

- Shock hemorrágico - protocolo de transfusión masiva

- 1er y 2do pabellón hemotórax con drenaje e instalación de pleurostomía, laceración aortica surparrenal con hematoma retroperitoneal, se realizó arteriorrafia.

- 14/02 pabellón retiro de packing

Shock séptico y bacteriemia por *S. marcescens* NDM, obs ITS CVC resuelta

Pancreatitis necrohemorrágica - 17/02 necrosectomía corpocaudal.

22/02 Perforación intestinal (hallazgo) - enterorrafia + cierre parcial de aponeurosis con malla.

26/02 Pabellón para aseo

02/03 Cierre abdominal

15/03 Drenaje pleural y pleurodesis.

16/03 Aseo de cicatriz dehiscente.

25/03 Aseo y drenaje de hemotórax, cambio de VAC.

Peritonitis por *C. albicans* y SAMR.

04/04 retiro de pleurostomía y cierre de pared abdominal.

Durante su estadía en sala, presenta buena evolución clínica y buena respuesta a la rehabilitación, progresivamente mejora su tono muscular permitiendo deambular sin apoyo.

Hemodinámico: Titulándose atenolol para manejo de adrenérgica y como antihipertensivo, primeras semanas con delirium hiperactivo, y posteriormente controlado, sin necesidad de contención.

Respiratorio: TQT en rehabilitación, destetado de ventilador 11/04, en seguimiento y rehabilitación con fonoaudiología y KNT, logra decanularse el 16/05/22. Sin incidentes.

Infeccioso: Nuevos hemocultivos del 17/4/2022 son negativos nuevamente. Se realiza fondo de ojo que descarta la retinitisfúngica. mantener una conducta expectante. No ha presentado nuevos focos infecciosos, con control de laboratorio el 10/05/22. PCR: 5.5 GB: 8.500 TAC de AP de control, se evidencia disminucion de colección en cola de páncreas.

Quirúrgico: Como complicación presenta dehiscencia de herida, misma que se resuelve, al momento con herida en optimas condiciones, cerrada. Presenta ademas fistula pancreática de bajo debito con drenaje JP. entre 10-30 cc/ día

Nutricional: parámetros nutricionales óptimos, se suspende NTE, tolera regimen oral, sin nauseas ni vómitos con transito intestinal.

Paciente actualmente en condiciones de alta.

Diagnóstico de Egreso

Herida Penetrante Toraco Abdominal -

Condición de Egreso Traslado

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Regimen oral, blando sin granos.

Reposo relativo, levantarse a diario con apoyo.

- Atenolol 50 mg 1 comp al día a permanencia

- Diazepam 10 mg c / noche por 15 días

- Fluoxetina 20 mg al día a permanencia

- Omeprazol 20 mg al día a permanencia

- Risperidona 1 mg c/ 12 horas por 15 días

- Paracetamol 1gr c/8 horas SOS

Controles

- Control con cirugía adulto en 2 semanas, solicitar hora con Dr Ramos en CDT pasillo 11. (lunes 30/05/22)

- Control con cirugía vascular en 1 mes, solicitar hora con hoja de epicrisis en CDT.

Fecha Epicrisis : 17/05/2022 17:39

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 17-05-2022 17:39:48

Página 4 de 4

- Control en su consultorio en salud mental y rehabilitación
- Control en servicio de urgencias en caso de vómitos, dolor, fiebre o en caso necesario

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Bec. Claudia Garcia Acaro

Becado/Residente

Tyare Fuentes Gonzalez

Médico Tratante (Staff)